

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1397

19 de agosto de 2026

Presentado por señor *Ríos Santiago*

Referido a la

LEY

Para enmendar el Artículo 1.02, añadir nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1), (dd-2) y (nn-1) al Artículo 1.03, añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04, añadir un nuevo Artículo 5.11-A, enmendar el Artículo 5.16 y añadir un nuevo Artículo 5.18 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco regulatorio para los medicamentos compuestos de alto riesgo y las farmacias no residentes que permita la responsable protección salubrista de los pacientes localizados en Puerto Rico; sin imponer requisitos duplicativos a farmacias físicamente localizadas en la jurisdicción de Puerto Rico, debidamente licenciadas bajo la Ley 247-2004; requerir la publicación de informes bianuales por parte de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARPS) junto con la Oficina de Planificación y Desarrollo sobre la supervisión de las prácticas de preparación de medicamentos compuestos; garantizar una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias para proteger a los pacientes de medicamentos preparados ilegalmente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preparación ilegal de medicamentos compuestos representa un desafío creciente y de gran magnitud en Puerto Rico, que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la integridad del sistema de salud. Los ciudadanos merecen medicamentos en los que puedan confiar, que sean seguros, efectivos y elaborados conforme a los más altos estándares de calidad establecidos por las regulaciones estatales y federales. Sin

embargo, en los últimos años, se ha observado un aumento alarmante en la distribución de medicamentos compuestos sin la supervisión adecuada, lo que constituye una amenaza significativa para la salud pública. Este problema es particularmente pronunciado en el caso de los medicamentos GLP-1 utilizados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, aunque se extiende a otras clases de medicamentos, afectando a diversos sectores de la población.

La preparación de medicamentos compuestos, cuando se realiza conforme a las normativas, es una práctica esencial que permite adaptar tratamientos a las necesidades específicas de los pacientes. No obstante, la proliferación de actividades de preparación ilegal, especialmente en entornos no regulados como spas médicos y clínicas de bienestar, ha evidenciado un vacío regulatorio que trasciende la mera supervisión del establecimiento físico o del profesional que realiza el procedimiento. El problema salubrista no radica únicamente en la práctica estética, sino en el manejo y administración de medicamentos compuestos cuya naturaleza requiere controles y supervisión especializada. Cuando estos productos son preparados sin receta individual previa, adquiridos como ingredientes farmacéuticos activos sin adecuada trazabilidad, o prescritos mediante evaluaciones insuficientes, se desdibuja la línea entre la composición farmacéutica legítima y la manufactura no regulada. Ello coloca al paciente en una posición de vulnerabilidad y dificulta la intervención temprana del Estado ante eventos adversos o prácticas negligentes. Estos establecimientos, que a menudo operan sin la fiscalización de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (en adelante, SARPS) y la Junta Examinadora de Farmacia en materia de medicamentos, representan puntos ciegos regulatorios. Los actores malintencionados aprovechan estas lagunas legales y de cumplimiento para producir y comercializar medicamentos no aprobados a una escala sin precedentes, exponiendo a los pacientes a riesgos graves, como la administración de productos ineficaces, contaminados o potencialmente peligrosos.

A esta realidad se suma el aumento en la dispensación y envío de medicamentos compuestos hacia Puerto Rico por parte de farmacias ubicadas fuera de la jurisdicción,

comúnmente denominadas farmacias no residentes. Si bien estas entidades pueden estar autorizadas en sus estados de origen, su operación hacia pacientes en Puerto Rico plantea retos particulares de fiscalización, acceso a información regulatoria y capacidad de respuesta ante eventos adversos o incumplimientos. La ausencia histórica de un mecanismo uniforme de registro y supervisión local ha limitado la visibilidad de las autoridades regulatorias sobre el volumen, naturaleza y riesgos asociados a medicamentos compuestos que ingresan a la jurisdicción desde el exterior, especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo.

A lo anterior, se añade la limitada disponibilidad de información pública sobre las acciones de fiscalización que realizan las entidades reguladoras para atender esta problemática. Actualmente, no existe un mecanismo sistemático de recopilación y divulgación que permita conocer, entre otros aspectos, el número de farmacias no residentes que preparan o dispensan medicamentos compuestos para pacientes localizados en Puerto Rico, las inspecciones efectuadas, la naturaleza de las violaciones detectadas, las investigaciones iniciadas ni las medidas correctivas o disciplinarias impuestas. Esta insuficiencia de datos dificulta la evaluación objetiva de la efectividad del marco regulatorio vigente y limita la capacidad del Estado para asignar recursos y diseñar estrategias basadas en evidencia que fortalezcan la protección de los pacientes.

Por todo lo cual, resulta imperativo enmendar la “Ley de Farmacia de Puerto Rico” para establecer un marco legal abarcador que regule y supervise específicamente los medicamentos compuestos de alto riesgo, independientemente del entorno en que se administren. Una legislación integral debe definir con claridad estos medicamentos, imponer requisitos de receta individualizada, asegurar la trazabilidad de los ingredientes activos, exigir notificación de eventos adversos y facultar a las autoridades sanitarias para fiscalizar su preparación y dispensación. Solo mediante un régimen normativo coherente y robusto podrá el Estado cumplir con su deber indelegable de proteger la salud pública, garantizar la seguridad del paciente y prevenir que prácticas comerciales emergentes comprometan estándares básicos de calidad y responsabilidad sanitaria.

Ante este escenario, esta Ley enmienda la “Ley de Farmacias de Puerto Rico” para establecer un marco robusto de transparencia, registro y rendición de cuentas en la supervisión de la preparación y dispensación de medicamentos compuestos, particularmente aquellos clasificados como de alto riesgo. Como componente esencial, se dispone el requisito de registro de farmacias no residentes que envíen, dispensen o distribuyan medicamentos compuestos a pacientes en Puerto Rico, con el propósito de permitir a las autoridades regulatorias identificar, evaluar y supervisar de manera más efectiva estas operaciones extraterritoriales con impacto directo en la salud pública local. Dicho registro facilitará el acceso a información sobre licencias vigentes, historial disciplinario, cumplimiento con estándares federales aplicables y volumen de operaciones hacia la jurisdicción, fortaleciendo la capacidad de vigilancia y respuesta regulatoria.

Mediante la implementación de requisitos de informes periódicos, se proveerá a la Asamblea Legislativa, a las entidades reguladoras y al público información clara y estandarizada sobre las actividades de licenciamiento, registro, inspección, investigación y disciplina relacionadas con establecimientos no residentes que manejen medicamentos compuestos. Estos informes permitirán identificar tendencias, riesgos emergentes y necesidades de recursos humanos y materiales, fortaleciendo la capacidad institucional de fiscalización.

En última instancia, esta legislación tiene como objetivo fortalecer la protección de los pacientes puertorriqueños, asegurando que los medicamentos que reciben sean seguros, efectivos y elaborados bajo estrictos estándares de calidad. Al promover una supervisión más efectiva, y coordinada y transparente entre la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), incluyendo supervisión de farmacias no residentes, esta Ley constituye un paso esencial para los riesgos asociados a la preparación ilegal de medicamentos y para preservar la confianza pública en el sistema de salud.

La Asamblea Legislativa reconoce que las farmacias localizadas físicamente en Puerto Rico, debidamente licenciadas, que realizan composición farmacéutica, incluyendo farmacias 503A, ya se encuentran sujetas a licenciamiento, inspección y fiscalización directa bajo la Ley 247-2004, los reglamentos promulgados por el Departamento de Salud, la Junta Examinadora de Farmacia, leyes y reglamentos federales y los estándares USP aplicables. Por tanto, esta Ley no tiene el propósito de duplicar permisos, autorizaciones, reportes ni cargas administrativas sobre dichas farmacias residentes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.02 de la Ley 247-2004, según enmendada,
2 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 1.02. — Propósito.

4 El propósito de esta Ley es promover, preservar y proteger la salud, la
5 seguridad y el bienestar público mediante el control y reglamentación efectivo de la
6 práctica de farmacia *no residente* y el licenciamiento, control y reglamentación de los
7 establecimientos y personas que manufacturan, distribuyen, dispensan y expenden
8 medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención
9 de enfermedades *a pacientes localizados* en **[el Estado Libre Asociado]** de Puerto Rico,
10 *independientemente del lugar físico donde se origine el despacho. [Esta Ley no regula o*
11 **afecta de modo alguno lo referente al mercadeo de medicamentos por correo desde**
12 **los Estados Unidos o el extranjero a la jurisdicción territorial del Estado Libre**
13 **Asociado de Puerto Rico.]**

1 Sección 2. - Se añaden los nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1) (dd-2)
2 y (nn-1) al Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley
3 de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

4 “Artículo 1.03. — Definiciones.

5 A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado
6 que a continuación se indica:

7 (a) ...

8 ...

9 (k) ...

10 (k-1) *Dispensación a paciente localizado en Puerto Rico* – La dispensación o despacho
11 *que se realiza por una farmacia no residente a un paciente, prescribiente cuya dirección de*
12 *entrega se encuentra en Puerto Rico.*

13 (l) ...

14 ...

15 (u) ...

16 (u-1) *Evento Adverso* - *Cualquier acontecimiento médico desfavorable que ocurra*
17 *durante o después del uso de un medicamento y respecto del cual exista una sospecha razonable*
18 *de asociación con dicho medicamento, independientemente de que dicha relación causal haya*
19 *sido confirmada.*

20 (u-2) *Evento Adverso Grave* - *Un evento adverso que resulte en cualquiera de los*
21 *siguientes resultados: muerte, una experiencia que ponga en peligro la vida, hospitalización de*
22 *un paciente; una incapacidad o discapacidad persistente o significativa, una anomalía*

1 *congénita o defecto de nacimiento, o un evento que requiera, según el juicio médico razonable,*
2 *una intervención médica o quirúrgica para prevenir alguno de los resultados antes descritos.*

3 (v) ...

4 (aa) ...

5 (aa-1) *Farmacia no residente – Establecimiento de servicio de salud dedicados a la*
6 *prestación de servicios farmacéuticos, que incluye: la dispensación de medicamentos de receta,*
7 *medicamentos sin receta, artefactos y otros productos relacionados con la salud, la prestación*
8 *de cuidado farmacéutico y otros servicios dentro de las funciones del farmacéutico establecidas*
9 *en esta Ley, incluyendo a instalaciones 503A, localizadas fuera de Puerto Rico que ejerza*
10 *dispensación a paciente localizado en Puerto Rico por correo, mensajería, telemedicina o*
11 *cualquier otro método remoto.*

12 (bb) ...

13 ...

14 (dd) ...

15 (dd-1) *Ingrediente farmacéutico activo - Toda sustancia destinada a incorporarse en un*
16 *medicamento terminado y que tenga por objeto proporcionar actividad farmacológica u otro*
17 *efecto directo en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades, o*
18 *afectar la estructura o cualquier función del organismo humano. El término no incluirá los*
19 *intermediarios utilizados en la síntesis de dicha sustancia ni los ingredientes inactivos del*
20 *medicamento, tales como agentes saborizantes o excipientes.*

21 (dd-2) *Facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo - el establecimiento*
22 *donde se creó originalmente un ingrediente farmacéutico activo mediante procedimientos o*

1 *manipulaciones químicas, físicas, biológicas o de otro tipo. No incluye a las droguerías ni los*
2 *distribuidores al por mayor de medicamentos.*

3 (ee) ...

4 ...

5 (nn) ...

6 (nn-1) *Medicamento compuesto de alto riesgo –Medicamento compuesto que, según el*
7 *reglamento adoptado por el Departamento de Salud con participación de la Junta Examinadora*
8 *de Farmacia y oportunidad de comentario público, presente riesgo significativo documentado*
9 *por razón de esterilidad, vía de administración, complejidad de preparación, historial de eventos*
10 *adversos, margen terapéutico estrecho o ausencia de controles adecuados de trazabilidad.*

11 *Ningún medicamento será clasificado como medicamento compuesto de alto riesgo salvo*
12 *que exista evidencia científica documentada de un riesgo significativo para la salud pública,*
13 *sustentada por informes de la Food and Drug Administration (FDA).*

14 *No se considerará automáticamente de alto riesgo toda preparación estéril por el solo*
15 *hecho de ser estéril. La determinación deberá basarse en criterios técnicos y evidencia*
16 *documentada.*

17 *No se considerará “Medicamento Compuesto de Alto Riesgo” la preparación estéril*
18 *realizada dentro de un hospital debidamente licenciado en Puerto Rico, cuando: sea realizada*
19 *por una farmacia institucional bajo la supervisión de un farmacéutico licenciado; se administre*
20 *exclusivamente a un paciente admitido o registrado; y responda a una orden médica válida,*
21 *receta o protocolo terapéutico institucional. Esta exclusión aplicará únicamente a hospitales y*
22 *no incluirá spas médicos, clínicas de bienestar, prácticas estéticas, clínicas ambulatorias*

1 *comerciales, consultorios no institucionales ni establecimientos análogos, independientemente*
2 *de su licenciamiento.*

3 (oo) ...

4 ...

5 (mmm) ...”

6 Sección 3. - Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04 de la Ley 247-2004,
7 según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea
8 como sigue:

9 “Artículo 5.04. — Medicamentos con requisitos especiales para su
10 dispensación.

11 (a) ...

12 ...

13 (e) ...

14 (f) *Medicamento compuesto de alto riesgo*

15 (i) *Para la composición y dispensación de medicamentos compuestos de alto*
16 *riesgo, las farmacias no residentes deberán solicitar y obtener del Secretario una*
17 *autorización especial para la dispensación de tales medicamentos conforme a los*
18 *requisitos que se establezcan mediante reglamento. Ninguna farmacia no*
19 *residente, podrá dispensar medicamentos compuestos de alto riesgo sin contar*
20 *con dicha autorización especial vigente.*

21 (ii) *Toda farmacia no residente que obtenga la autorización del Secretario para*
22 *la dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, al momento de su*

solicitud inicial y en cada renovación, deberá presentar ante el Secretario, o la secretaría, división o junta que este designe, una declaración de divulgación de la actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos preparados y dispensados por dicha farmacia no residente a pacientes localizados en Puerto Rico que debe al menos incluir:

1. Las categorías de medicamentos compuestos preparados, incluyendo si son estériles o no estériles;

2. La cantidad total de unidades de medicamentos compuestos preparadas durante el período de licencia anterior, clasificadas en preparaciones estériles y no estériles;

3. Una descripción de si los medicamentos compuestos se dispensan para administración en la farmacia, en un consultorio médico, dispensación directa al paciente o distribución a otras facilidades;

4. El número de pacientes atendidos con medicamentos compuestos durante el período del informe; y

5. Cualquier información adicional que la normativa exija razonablemente para evaluar la escala y el perfil de riesgo de las actividades de preparación de medicamentos compuestos.

6. Toda farmacia no residente deberá incluir en su declaración de divulgación de la actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos preparados y dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico:

- 1 a) Una copia del informe más reciente de inspección del estado
2 donde está físicamente operando; y
3 b) Una descripción de cualquier acción disciplinaria impuesta
4 por cualquier organismo regulador en contra de dicha farmacia
5 no residente.

6 (iii) Independientemente de la obtención de una autorización especial para la
7 dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, se prohíbe:

- 8 1. El envío directo a spas médicos, clínicas estéticas, centros de bienestar
9 o establecimientos no institucionales no autorizados por la Secretaría
10 Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del
11 Departamento de Salud de Puerto Rico;
12 2. La dispensación basada en protocolos estandarizados sin evaluación
13 clínica individualizada;

14 (iv) Todo medicamento compuesto de alto riesgo deberá entregarse acompañado
15 de:

- 16 1. nombre y dirección de la farmacia preparadora;
17 2. nombre del farmacéutico responsable;
18 3. número de lote o identificación de preparación;
19 4. fecha de preparación y fecha de expiración clínica;
20 5. advertencia visible indicando que el producto es un medicamento
21 compuesto no aprobado por la Food and Drug Administration (FDA),
22 6. Información de contacto para reportar eventos adversos; y

1 7. Rotulación adecuada en cumplimiento con el Artículo 5.02 (d) de esta
2 Ley.

3 (v) Las farmacias no residentes solo podrán vender, transferir o distribuir
4 medicamentos compuestos de alto riesgo si se cumplen los siguientes requisitos:

5 1. El ingrediente farmacéutico activo cumple con la Sección
6 503A(b)(1)(A) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y
7 Cosméticos (21 U.S.C. § 353a(b)(1)(A));

8 2. El ingrediente farmacéutico activo es un producto de grado
9 farmacéutico para uso humano;

10 3. El ingrediente farmacéutico activo está acompañada de una
11 certificación válida que contenga la identidad, pureza y potencia del
12 ingrediente farmacéutico activo, así como cualquier información
13 adicional que requiera el Secretario;

14 4. Todo ingrediente farmacéutico activo que no esté descrito en la
15 Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopeia) o del
16 Formulario Nacional (National Formulary):

17 a. estará acompañado de documentación de pruebas adecuadas de
18 control de calidad realizadas por la facilidad que fabrica un
19 ingrediente farmacéutico activo, un fabricante subsiguiente o un
20 distribuidor al por mayor, que:

21 i. confirmen la identidad y el contenido del ingrediente
22 farmacéutico activo;

1 ii. informen, identifiquen, caractericen y cuantifiquen
2 cada impureza y solvente residual presente en el
3 ingrediente farmacéutico activo en una cantidad que
4 exceda una décima de uno por ciento (0.1%); y
5 iii. contengan cualquier información adicional que pueda
6 requerir el Secretario; o

7 b. antes de utilizar el ingrediente farmacéutico activo en la
8 preparación del medicamento compuesto de alto riesgo, la
9 persona dedicada a la preparación deberá obtener pruebas
10 adecuadas de control de calidad que contengan la información
11 especificada en el Artículo 5.04(f)(vi)(4)(a)(i)-(iii). La
12 información de control de calidad requerida por este Artículo
13 5.04(f)(vi)(5) podrá incluirse en la certificación descrita en el
14 Artículo 5.04(f)(vi)(3).

15 (vii)(a) Toda farmacia no residente deberá mantener documentación verificable
16 de que el ingrediente farmacéutico activo fue fabricado en una facilidad que
17 fabrica un ingrediente farmacéutico activo que:

18 1. está debidamente registrado ante la Food and Drug Administration
19 (FDA) bajo la Sección 510 del Food, Drug and Cosmetic Act (21 U.S.C.
20 360);

1 2. ha sido sometido a una inspección por parte de la Food and Drug
2 Administration (FDA) como establecimiento de medicamentos para uso
3 humano;

4 3. no está actualmente sujeto a una inspección no resuelta por parte de
5 la Food and Drug Administration (FDA) que fue clasificada como
6 “Acción Oficial Indicada”(“Official Action Indicated”);

7 4. Actualmente no está sujeto a ninguna Alerta de Importación emitida
8 por la Food and Drug Administration (FDA); y

9 5. no está actualmente sujeto a una Carta de Advertencia no resuelta de
10 la Food and Drug Administration (FDA).

11 La documentación requerida por este párrafo también debe incluir: País de
12 origen, dirección y número de identificación de establecimiento de la Food and
13 Drug Administration (FDA) de la Facilidad que fabrica un ingrediente
14 farmacéutico activo.

15 (b) Es ilegal que cualquier fabricante o mayorista venda, transfiera o distribuya
16 un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la preparación de compuestos
17 sin proporcionar al comprador la certificación requerida en el Artículo
18 5.04(f)(vi)(3), la documentación de pruebas de control de calidad y la
19 verificación escrita descrita en el Artículo 5.04(f)(vi)(3) al Artículo
20 5.04(f)(vi)(4) y el Artículo 5.04(f)(viii)(a).

1 (viii) La preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo deberá cumplir
2 con el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, incluyendo las disposiciones de la
3 Sección 503A (21 U.S.C. 353a).

4 (ix) (a) Las farmacias no residentes que se dedican a la venta, transferencia o
5 distribución de medicamentos compuestos de alto riesgo deberán mantener todos
6 los registros relacionados con la adquisición, el examen y la prueba del
7 ingrediente farmacéutico activo durante no menos de dos (2) años después de la
8 fecha de vencimiento del último lote de medicamento compuesto de alto riesgo
9 que contenga el ingrediente farmacéutico activo y, a solicitud del Secretario,
10 deberán proporcionar dichos registros dentro de un tiempo razonable según lo
11 determine el Secretario en función de las circunstancias de la solicitud.

12 (b) El Secretario o la secretaría, división o junta que este designe, tendrá la
13 facultad de requerir a cualquier farmacia no residente que venda, transfiera o
14 distribuya medicamentos compuestos de alto riesgo, así como cualquier
15 Facilidad que fabrique un ingrediente farmacéutico activo, fabricante posterior
16 o Distribuidor al por mayor de medicamentos que venda, transfiera o distribuya
17 un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la preparación de compuestos,
18 la documentación, certificaciones, autorizaciones o licencias necesarias para
19 verificar el cumplimiento con los requisitos del Artículo 5.04(f)(v) al Artículo
20 5.04(f)(viii). Negarse a proveer documentación requerida por el Secretario o la
21 secretaría, división o junta que este designe para verificar el cumplimiento con

1 *los requisitos del Artículo 5.04(f)(v) al Artículo 5.04(f)(viii) constituirá una*
2 *violación a esta Ley.*

3 *(c) El Secretario está autorizado a promulgar las reglas que sean necesarias para*
4 *implementar esta Ley.*

5 *(x)(a) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vi), 5.04(f)(vii) y 5.04(f)(viii) darán lugar*
6 *a:*

7 *1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada dosis del medicamento compuesto*
8 *de alto riesgo vendida, transferida o distribuida; y*

9 *2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de medicamentos o de*
10 *Droguería y cualquier otra licencia, certificado, registro o autorización emitida*
11 *por el Secretario de Salud.*

12 *(b) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vii)(b) de esta Ley darán lugar a:*

13 *1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada miligramo del ingrediente*
14 *farmacéutico activo distribuido ilegalmente; y*

15 *2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de medicamentos o de*
16 *Droguería.*

17 *(c) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(ix) resultarán en una multa de \$5,000 y*
18 *darán lugar a la revocación de la licencia correspondiente.*

19 *(xi) Todo farmacéutico que conozca de un evento adverso asociado a un*
20 *medicamento compuesto de alto riesgo dispensado o administrado a un paciente*
21 *localizado en Puerto Rico deberá notificarlo al Departamento de Salud dentro de*
22 *diez (10) días laborables desde que advenga en conocimiento, en caso de un evento*

1 *adverso grave, deberá notificarlo al Departamento de Salud dentro de cinco (5) días*
2 *laborables desde que advenga en conocimiento.”*

3 Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.11-A a la Ley 247-2004, según
4 enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como
5 sigue:

6 “Artículo 5.11. — Farmacia.

7 (a)...

8 ...

9 (i) ...

10 Artículo 5.11-A. – *Farmacia no residente con dispensación a paciente localizado en*
11 *Puerto Rico.*

12 (a) *Ninguna farmacia no residente podrá dispensar, enviar, entregar, causar la entrega,*
13 *facturar o de cualquier forma proveer medicamentos a pacientes localizados en Puerto Rico sin*
14 *previamente registrarse ante la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública*
15 *(SARSP) del Departamento de Salud de Puerto Rico como farmacia no residente y recibir un*
16 *certificado de registro de farmacia no residente.*

17 (b) *Para configurar un registro válido y obtener un certificado de registro de farmacia*
18 *no residente la farmacia no residente deberá presentar:*

- 19 1. *Una licencia vigente y en buen estado en la jurisdicción donde ubique*
20 *físicamente;*
21 2. *Aprobación del National Association of Boards of Pharmacy Digital*
22 *Pharmacy Accreditation Program;*

1 3. Identificar un representante de cumplimiento regulatorio para pacientes
2 localizados en Puerto Rico, quien fungirá como punto de contacto principal ante
3 el Departamento de Salud y responderá ante cualquier evento de
4 incumplimiento con esta Ley. Un representante no podrá ser designado
5 responsable para más de una farmacia no residente.

6 4. Designar un agente representante en Puerto Rico autorizado a recibir
7 notificaciones administrativas y judiciales;

8 5. Presentar una declaración jurada certificando y haciendo constar que una vez
9 registrada la farmacia no residente cumplirá con:

10 (i) someter certificaciones de cumplimiento con estándares aplicables de
11 preparación y manejo de medicamentos;

12 (ii) Mantener y proveer, a requerimiento del Departamento de Salud de
13 Puerto Rico documentación verificable relacionada con recetas,
14 preparación, dispensación y envío de medicamentos a pacientes
15 localizados en Puerto Rico;

16 (iii) Notificar al Departamento de Salud de Puerto Rico cualquier evento
17 adverso con medicamentos dispensados o administrados a pacientes
18 localizados en Puerto Rico dentro de un término no mayor de diez (10)
19 días laborables o en casos de evento adverso grave en cinco (5) días
20 laborables contados en ambas instancias desde que advenga en
21 conocimiento o razonablemente debió haber conocido de dicho evento.

22 (iv) Cumplir con los requisitos de reporte establecidos en esta Ley.

1 6. Sufragar los derechos establecidos en el Artículo 5.16 de esta Ley.

2 (c) *Requisitos de Reporte.* Toda farmacia no residente registrada ante la Secretaría
3 *Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto*
4 *Rico, que a su vez haya obtenido la autorización de medicamentos compuestos de alto riesgo,*
5 *deberá al momento del registro y renovación presentar una declaración de divulgación de la*
6 *actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos*
7 *preparados y dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico de conformidad con el Artículo*
8 *5.04(f) de esta Ley.*

9 (d) *Al cumplir con los parámetros de este Artículo, la Secretaría Auxiliar para la*
10 *Regulación de la Salud Pública (SARSP) emitirá un Certificado de Registro de farmacia no*
11 *residente. El Certificado de Registro de farmacia no residente será válido por un (1) año. El*
12 *mismo debe ser renovado anualmente mediante presentación de los documentos requeridos en*
13 *este Artículo al menos cuarenta y cinco (45) días antes de su vencimiento.*

14 (e) *Ningún plan médico, aseguradora, administrador de beneficios de farmacia (PBM),*
15 *hospital, clínica, farmacia o proveedor de salud establecido en Puerto Rico y regulado por las*
16 *leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá pagar, procesar, adjudicar o reembolsar*
17 *reclamaciones por medicamentos dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico por*
18 *farmacias no residentes no registradas conforme a esta Ley.*

19 (f) *Ningún profesional de la salud autorizado a ejercer en Puerto Rico y sujeto a las*
20 *leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá ordenar, coordinar la dispensación ni*
21 *administrar medicamentos a través de una farmacia no residente no registrada.*

1 (g) *El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la Regulación*
2 *de la Salud Pública (SARSP), está facultado para:*

- 3 1. *Emitir órdenes administrativas de cese y desista respecto a la dispensación de*
4 *medicamentos hacia pacientes localizados en Puerto Rico;*
5 2. *notificar a agencias regulatorias estatales o federales;*
6 3. *requerir a planes médicos o PBMs la denegación de reclamaciones*
7 *provenientes de farmacias no residente son registradas; y*
8 4. *establecer multas administrativas conforme a la Ley 38-2017, según*
9 *enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme*
10 *del Gobierno de Puerto Rico”.*

11 (h) *El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la Regulación*
12 *de la Salud Pública (SARSP), deberá:*

- 13 1. *Aprobar los reglamentos que sean necesarios para hacer cumplir lo dispuesto*
14 *en este Artículo.*
15 2. *Publicar el registro de farmacias no residentes.*

16 (i) *Nada en este Artículo autoriza a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la*
17 *Salud Pública (SARSP) ni al Departamento de Salud de Puerto Rico a regular las operaciones*
18 *internas de farmacias no residentes. La autoridad conferida se limita exclusivamente a la*
19 *protección de la salud pública respecto a la dispensación y administración de medicamentos a*
20 *pacientes localizados en Puerto Rico.*

21 (j) *Este Artículo se interpretará como una medida de salud pública dirigida*
22 *exclusivamente a regular la dispensación de medicamentos a pacientes localizados en Puerto*

1 *Rico y no como una regulación extraterritorial del ejercicio de la profesión de la farmacia fuera*
2 *de Puerto Rico.”*

3 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5.16 de la Ley 247-2004, según enmendada,
4 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

5 “Artículo 5.16. — Vigencia y derechos de licencias, certificados, *registros* y
6 autorizaciones.

7 (a) Las licencias *y registros* requeridas en este Capítulo, salvo lo relacionado al
8 Registro de Medicamentos *y al Certificado de Registro de Farmacia No Residente*, tendrán
9 dos (2) años de vigencia desde la fecha de su expedición y se renovarán en forma
10 escalonada, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que se
11 establezcan por reglamento y el pago de los correspondientes derechos; con excepción
12 de los certificados de registros de medicamentos y/o productos biológicos para
13 oficinas médicas, dentales y podiátricas, y para ensayos clínicos en instituciones de
14 educación superior u oficinas médicas, que tendrán tres (3) años de vigencia, y se
15 obtendrán mediante radicación del registro según la fecha de renovación de licencia
16 profesional del médico, dentista o podiatra, cuando corresponda. Además, será deber
17 del Departamento de Salud, en lo posible y mientras los recursos fiscales lo permitan,
18 el establecer los procedimientos para poder radicar y expedir mediante su página
19 electrónica gubernamental (Internet) la solicitud para obtener las licencias requeridas
20 en este Capítulo o el Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o Productos
21 Biológicos en Oficina Médica, y Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o

1 Biológicos para Ensayos Clínicos en Institución de Educación Superior *y el certificado*
2 *de registro de farmacia no residente.*

3 (b) ...

4 (c) Toda persona que opere más de un establecimiento de los definidos en esta
5 Ley, deberá solicitar y obtener una licencia, certificado, *registro* o autorización
6 separada para cada uno de los establecimientos.

7 (d) Las licencias, certificados, *registros* y autorizaciones no serán transferibles.

8 (e) La licencia, certificado, *registro* o autorización se expedirá a nombre del
9 dueño o razón comercial que la solicite y aplicará solamente al establecimiento en la
10 localización que se indique en la faz de la misma. Además, especificará el tipo de
11 establecimiento para el cual se otorga según definidos en esta Ley.

12 (f) Las licencias, certificados, *registros* y autorizaciones que se enumeran a
13 continuación pagarán los siguientes derechos que estarán vigentes desde la fecha de
14 aprobación de esta Ley hasta que el Secretario, mediante reglamento, establezca otros
15 derechos:

16 1. ...

17 ...

18 17...

19 18. *Certificado de Registro de farmacia no residente - \$500.*

20 (g) ...

21 (h) Los ingresos que se recauden por estos conceptos serán depositados en el
22 Fondo de Salud creado bajo las disposiciones del Artículo 11-A de la Ley Núm. 26 de

1 13 de noviembre de 1975, según enmendada, para uso exclusivo de la División de
2 Farmacia, en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en el Capítulo V
3 de esta Ley; *con excepción de los fondos que se recauden del Certificado de Registro de*
4 *Farmacia no residente. Los recaudos del Certificado de Registro de Farmacia no residente*
5 *deberán ser transferidos al Departamento de Salud para fortalecer las capacidades de la*
6 *Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP)."*

7 Sección 6 .- Se añade un nuevo Artículo 5.18 a la Ley 247-2004, según
8 enmendada, conocida como "Ley de Farmacia de Puerto Rico", para que lea como
9 sigue:

10 *Artículo 5.18. – Informe sobre Supervisión de la Preparación de Medicamentos*
11 *Compuestos.*

12 La Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) junto con la
13 Oficina de Planificación y Desarrollo, o cualquier otra secretaría, unidad, oficina o dependencia
14 que el Secretario del Departamento de Salud determine, desarrollará y publicará un informe
15 bianual sobre la supervisión de la preparación de medicamentos y los riesgos
16 compuestos asociados con dichas prácticas. Dicho informe incluirá los siguientes
17 elementos:

18 (a) El número de certificaciones a farmacias no residentes emitidas por el Secretario,
19 o la secretaría, división o junta que este designe, para la dispensación de
20 medicamentos compuestos de alto riesgo, incluyendo autorizaciones para la
21 dispensación de medicamentos estériles para uso parenteral o cualesquiera otros
22 medicamentos que requieran técnicas asépticas especiales.

1 (b) *El número de certificados de registro de farmacias no residentes emitidos por la*
2 *Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP).*

3 (c) *El número de instalaciones y prácticas licenciadas, autorizadas o registradas*
4 *que han sido inspeccionadas en el último año y en los últimos tres años,*
5 *desglosado por tipo de licencia, autorización o registro.*

6 (d) *El número de inspecciones realizadas a instalaciones y prácticas*
7 *involucradas en la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo, o en*
8 *el manejo, almacenamiento, administración, dispensación, distribución u otro*
9 *uso de medicamentos preparados en el ámbito minorista o ambulatorio,*
10 *incluyendo farmacias no residentes, pero excluyendo instalaciones de salud*
11 *licenciadas como hospitales o centros quirúrgicos ambulatorios.*

12 (e) *Una descripción de la naturaleza y gravedad de cualquier deficiencia o*
13 *posible violación observada durante las inspecciones o reportadas por*
14 *farmacéuticos.*

15 (f) *El número de investigaciones abiertas por el Departamento de Salud, o*
16 *cualquier otra agencia estatal a la que se le haya referido una investigación,*
17 *relacionadas con la preparación de medicamentos.*

18 (g) *El número y tipo de acciones disciplinarias tomadas por el Departamento de*
19 *Salud, o cualquier otra agencia estatal a la que se le haya referido una investigación,*
20 *relacionadas con la preparación de medicamentos compuestos.*

(h) Una evaluación de los recursos humanos y materiales de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), en relación con la escala estimada de la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo.

(i) Un análisis de la naturaleza y gravedad de los riesgos emergentes relacionados con la preparación de medicamentos compuestos *de alto riesgo*, y la distribución, comercialización y venta de medicamentos compuestos.

El primer informe se publicará a más tardar el 30 de septiembre de 2027, con datos correspondientes del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2027. Posteriormente, los informes se publicarán dos veces al año, a más tardar el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, conteniendo datos de los seis meses anteriores, respectivamente. *Los informes no contendrán información protegida por la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA).*

Los informes bianuales serán publicados en la *página electrónica oficial* de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) o del Departamento de Salud de Puerto Rico, además de estar disponibles para consulta pública sin costo alguno. *La Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) notificará al público sobre la publicación de cada informe mediante comunicados oficiales.*

Se prohíbe imponer cualquier cargo monetario a los ciudadanos, profesionales de la salud o instalaciones licenciadas para el cumplimiento *de la divulgación del informe bianual establecido en esta Sección.*

Sección 7.- Farmacias localizadas físicamente en la jurisdicción de Puerto Rico.

1 Nada de lo dispuesto en estas enmiendas, se interpretará como una limitación,
2 sustitución, duplicación o ampliación de los requisitos aplicables a farmacias
3 localizadas físicamente en la jurisdicción de Puerto Rico, debidamente licenciadas bajo
4 la Ley 247-2004. Estas farmacias, incluyendo las farmacias 503A que realicen
5 composición farmacéutica estéril o no estéril, continuarán reguladas por la “Ley de
6 Farmacia de Puerto Rico”, sus reglamentos, la Junta Examinadora de Farmacia, el
7 Departamento de Salud y los estándares de USP aplicables.

8 Sección 8.- Reglamentación.

9 El Secretario del Departamento de Salud está autorizado y deberá, dentro de
10 ciento ochenta (180) días de aprobada esta Ley, aprobar o enmendar los reglamentos
11 que sean necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley.

12 Sección 9.- Cláusula de separabilidad.

13 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
14 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la
15 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de
16 dictamen adverso.

17 Sección 10.- Vigencia.

18 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.